

Особенности злокачественных новообразований и их диагностики в детском возрасте.

Литературный обзор

Потапов А.В.

Центральная клиническая больница
Управления делами Президента РК, Алматы

Ересектермен салыстырғанда, балаларда кездесетін қатерлі түзілімнің өзіндік клиникалық, эпидемиологиялық және генетикалық сипаттағы ерекшеліктері бар. Балалар қатерлі түзілімін диагностикалау, ересек пациенттерден айырмашылығы бар. Мысалы, табиғаты эпителиалды ісік (рак) балаларда өте сирек кездеседі, ал саркомалар өте жиі. Балаларда 3 жасқа дейін кездесетін ісіктер туа пайда болған, ал ересектерде бұндай ісіктер 3-4% жағдайда кездеседі.

Malignant neoplasms in childhood have characteristic features in clinical, epidemiological and genetic development in compared with adults. Diagnostics of malignant neoplasms in children is also different from adult patients. For example,

Существуют характерные клинические, эпидемиологические и генетические признаки опухолей у детей. Так, например, опухоли эпителиальной природы (раки) у детей встречается не чаще, чем в 5-6% всех наблюдений, в тоже время саркомы встречаются практически в 84% случаев. Львиная доля всех злокачественных образований у детей по гистогенезу представлены производными мезенхимы и нейроэктодермы, в то время как у взрослых преобладают эпителиальные опухоли. В детском возрасте отмечается высокий удельный вес так называемых эмбриональных опухолей, составляющих в структуре заболеваемости около 40%, а у детей до 1 года – до 85% (Дурнов Л.А., 2003). В подавляющем большинстве случаев опухоли у детей до 3 лет – врожденные, у взрослых такие опухоли встречаются не более чем в 3-4% случаев. Сравнительно высокая частота злокачественных опухолей в первые годы жизни делает весьма вероятным предположение об антенатальном происхождении опухолей детского возраста (Дурнов Л.А., 2003).

Нередко опухоли и пороки развития органов и систем возникают одновременно. Целенаправленные исследования позволяют установить у подавляющего большинства детей с опухолями те или иные признаки дисморфизма. Так, например, крестцово-копчиковые тератомы могут сочетаться с различными опухолевыми образованиями нижнего отдела позвоночника, нижних отделов живота и урогенитальной области (Dahlin D.C., Umi K.K., 1986). У детей, страдающих крипторхизмом, в 35 раз повышен риск возникновения злокачественной опухоли. Риск увеличивается с ростом ребенка, а абдоминальная локализация в 4 раза озлокачивается, чем паховая. Гетеротипические или персистирующие ткани плода могут иметь предрасположенность к развитию опухолей. Так, они могут вызывать краниофарингиому в кармане Ратке, хордому из нотохордальных остатков ядер пульпы, светлоклеточную аденокарциному генитального тракта из остатков мезотелия, различные карциномы в области бронхиальных, щитоподъязычных кист, а также

Злокачественные новообразования в детском возрасте имеют характерные клинические, эпидемиологические и генетические особенности в сравнении со взрослыми. Диагностика злокачественных новообразований у детей также имеет отличия от взрослых пациентов. Так, например, опухоли эпителиальной природы (раки) у детей встречается редко, в тоже время саркомы встречаются очень часто. В подавляющем большинстве случаев опухоли у детей до 3 лет – врожденные, у взрослых такие опухоли встречаются не более чем в 3-4% случаев.

tumors of epithelial nature (c-r) in children is rare, at the same time sarcomas occur very often. The vast majority of tumors in children under 3 years old - congenital, in adults population, such tumors are not more than 3-4% of cases.

из остатков удвоенной кишки и дефектов билиарного тракта (Hanson J.W., 2006). Описана группа синдромов, которые могут дать ценную информацию при изучении генетики опухолевых заболеваний. Острый лейкоз описан при синдроме Rubinstein-Taubi (короткий роста, задержку развития, аналогичные черты лица, и широкие пальцы ног и первый), аномалии Poland (отсутствие большой грудной мышцы и синдактилия), синдроме Шварцмана (экзокринная поджелудочная недостаточность и нейтропения). Гепатобластома описана при синдроме Beckwith-Wiedemann. Саркомы мягких тканей нередко обнаруживаются Li-Fraumeni), болезни Ретлинггаузера. Опухоль Вилмса сочетаются с нейрофиброматозом, синдромом Drash (псевдогермафродитизм, гломеруллопатия и опухоль почки), с пороками мочеполовой системы – крипторхизм, гипоспадия, дисгения гонад, особенно у мальчиков, с нейрофиброматозом Perlmann (двухсторонняя почечная гамартома, макросомия, гипертрофия клеток поджелудочной железы, необычное лицо). Болезнь Ходжкина часто встречается у детей с таким синдромом, как атаксия-телеангиоэктазия (Дурнов Л.А., 2003; Hanson J.W., 2006).

К следующей особенности опухолей в детском возрасте можно отнести то, что около половины всех опухолей у детей, не принимая во внимание ранний детский возраст, занимают гемобласты (острый лейкоз, злокачественные лимфомы, лимфогранулематоз). Значительный удельный вес приходится на опухоли ЦНС, затем следуют новообразования забрюшинного пространства, такое распределение отмечено в большинстве стран мира, о чем было отмечено в эпидемиологическом обзоре выше.

Из солидных злокачественных новообразований в педиатрической практике наиболее часто встречаются новообразования головного мозга (15-20%), опухоли брюшной полости и забрюшинного пространства (в том числе нефробластома - 6-8% и нейробластома 5-7%), саркомы мягких тканей (8%) и костей (5-6%), ретинобластома (2-4%) (Дурнов Л.А., 2003; Арзыкулов Ж.А., Сейтказина Г.Ж., Жумадуллаев Б.М., 2006)

Опухоли центральной нервной системы – наиболее частые солидные опухоли у детей. Большинство опухолей головного мозга (70-80%) у детей возникают из глиальных клеток не метастазируют за пределы ЦНС до проведения оперативных вмешательств (Ланцовский Ф., 2005).

Большинство злокачественных новообразований у детей отличаются значительно более высокой чувствительностью к химиолучевой терапии, чем у взрослых, что определяет более благоприятный прогноз. При многих злокачественных опухолях у детей длительный период ремиссии можно добиться у 70-90% пациентов (Чиссов В.И., Дарьялова С.Л., 2007).

В успехах, достигнутых в лечении злокачественных опухолей у детей, решающее значение играет своевременная диагностика на ранних этапах его развития (Дурнов Л.А., 2006). Однако диагностика в онкологической практике у детей имеет свои особенности. Во-первых, невозможность получения анамнеза от самого пациента, (речь идет о детях раннего возраста), отсутствием жалоб. Поэтому приходится прибегать к расспросу родителей и ближайших родственников, а этот анамнез далеко не равноценен анамнезу, полученному от больного. Вторая особенность характеризуется относительно малым числом визуально обнаруживаемых опухолей. У детей встречается как казуистика рак молочной железы, рак шейки матки, рак пищевода и желудка (большинство из

которых доступны эндоскопическому исследованию). Третьей особенностью диагностики опухолей в педиатрической практике относится расположение наиболее часто встречающихся опухолей в труднодоступных для исследований областях: черепная коробка (опухоли ЦНС), забрюшинное пространство (нейробластома и нефробластома). Опухоли, локализующиеся в этих областях нередко растут длительно не вызывая видимых объективных изменений. Раздвигая окружающие органы и ткани, новообразования, постепенно увеличиваются в размере и часто обнаруживаются лишь тогда, когда достигают значительной величины, или, как это нередко бывает при нейробластоме, дают метастазы в отдаленные органы и ткани (Чиссов В.И., Дарьялова С.Л., 2007). Следующей особенностью диагностики онкопатологии в детском возрасте является то, что существует большое количество «масок», под которыми скрываются злокачественные опухоли. Практически любое заболевание в раннем детском возрасте, да и некоторые физиологические состояния могут быть похожи своими проявлениями на опухолевый процесс и наоборот (Чиссов В.И., Дарьялова С.Л., 2007).

Диагностический процесс в современной педиатрической онкологии это сложный комплекс мероприятий, начинающийся с расспроса родителей и ребенка (если это возможно), осмотра последнего и включающий в себя применение целого ряда специальных методик, основное место среди которых занимают методы лучевой диагностики.